

真珠腫性中耳炎について

殿

年 月 日 説明者:耳鼻咽喉科医師 高橋克昌

●真珠腫性中耳炎とは

鼓膜の裏側に塊ができた状態です。頭蓋骨を破壊するので摘出手術が必要です。原因は3つのパターンがあります。

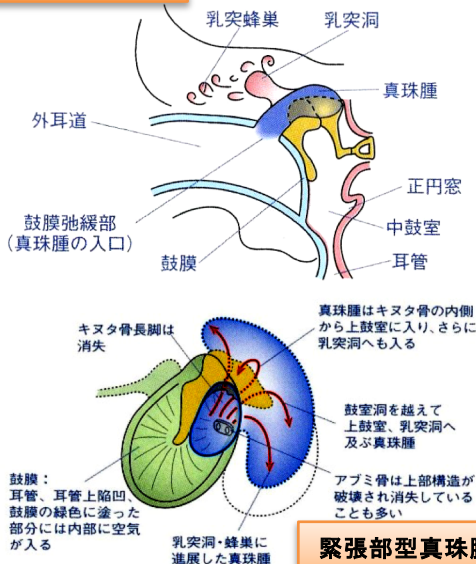
- ① **弛緩部型**：子供の頃は耳と鼻が悪くて病院に通っていた人が多いです。飛行機に乗って耳が詰まっても、耳抜きができない人で、耳と鼻とをつなぐ耳管の機能不全が原因です。
- ② **緊張部型**：中耳炎を放置していたのが原因です。
- ③ **先天性（生まれつき）**：子供の頃に偶然、健康診断で難聴として見つかることが多いです。

●真珠腫性中耳炎の症状

陥凹した部分に汚れが貯まり、感染します。鼓膜が溶けて穴が大きくなります。音を伝える骨も溶けてしまい、難聴が進行します。やがて頭蓋骨の破壊が進み脳神経の症状を伴います。

- ・耳漏（耳だれのことです）・耳痛（耳が痛くなります）
- ・伝音難聴（音が内耳にうまく伝わりません）
- ・感音難聴や耳鳴（病変が中耳を超えて内耳に及びます）
- ・めまい（三半規管が破壊されます：次ページも参照）
- ・顔面麻痺や味覚障害（徐々に神経も侵されます：次ページも参照）
- ・頭蓋内合併症（髄膜炎や脳膿瘍など、もはや命にかかわります）

弛緩部型真珠腫



緊張部型真珠腫

●診断と治療に必要な検査

ファイバーや顕微鏡による鼓膜所見で疑い、側頭骨CTで骨破壊像を確認します。腫瘍や炎症性病変との鑑別のためにMRIを撮影することもあります。

聴力検査も手術前後に行います。

また、細菌検査で抗生剤の効き具合を調べて、術後に使用する薬を選択します。

その他、味覚検査や、三半規管の障害を確認するために平衡機能検査（温度刺激検査）を行うこともあります。

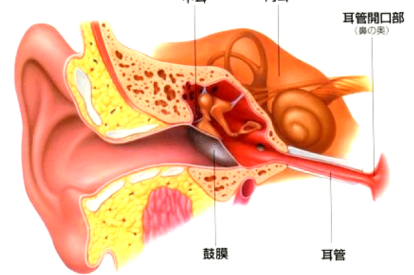
●治療について

ステージ1：鼓膜が陥凹しているのみでは、定期的な清掃で済みます。感染を伴うと洗浄や抗生剤の投与をしますが、徐々に薬が効かなくなってきました。無症状でも、都合がつけば、進行しない今のうちに予防目的の手術を勧めます。

ステージ2：耳小骨が破壊されているので難聴があるはずですが。壊れた骨は戻せないなので、手術後も聴力は改善しにくいです。ステージ3になる前に待機手術を勧めます。

ステージ3：脳神経症状が出ると手術しても症状は回復しません。早めの手術を勧めます。

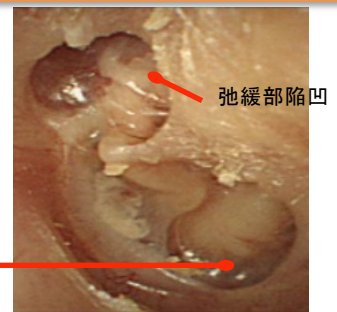
[1/2]



正常鼓膜・左耳



真珠腫性中耳炎



先天性真珠腫

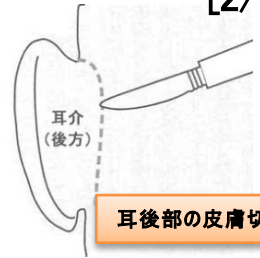


●鼓室形成術について

耳たぶの後ろを切って、耳の穴（外耳道）の周りの骨を削り、鼓膜の裏から頭蓋骨に入って、顕微鏡で拡大しながら行う細かい手術です。3-5時間の全身麻酔で行います。

鼓膜の裏には、味覚の神経、顔面神経、めまいの神経などがあり、真珠腫が絡みついています。神経を傷つけないように真珠腫だけを摘出するので、真珠腫を取り残すことも多く、2回目の手術で約半数に再発が見られます。

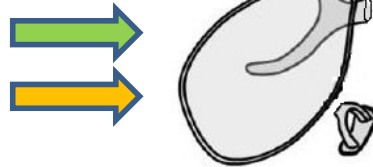
1年後にもう一度、同じ手術をして僅かでも取り残しがないか確認します。2回目でも真珠が見られたら3回目を予定します。癌の場合なら、顔面神経が麻痺してでも大きく完全摘出しますが、良性の真珠腫では、何回手術しても良いから顔が麻痺しない手術方法をとります。複数回に分けて手術をするため、**段階的鼓室形成術**と呼びます。



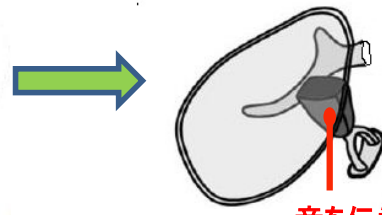
初回手術



耳小骨の周りに真珠腫が絡んでいます



耳小骨の一部とともに真珠腫を摘出（鼓膜とアブミ骨がはなれてしまいました）



鼓膜とアブミ骨が再び連結しています(伝音再建)

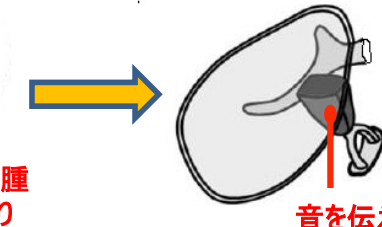
→ は、一期的手術の流れです

→ は、段階的手術です。再手術までは鼓膜とアブミ骨は離ればなれです(伝音性難聴)

再手術

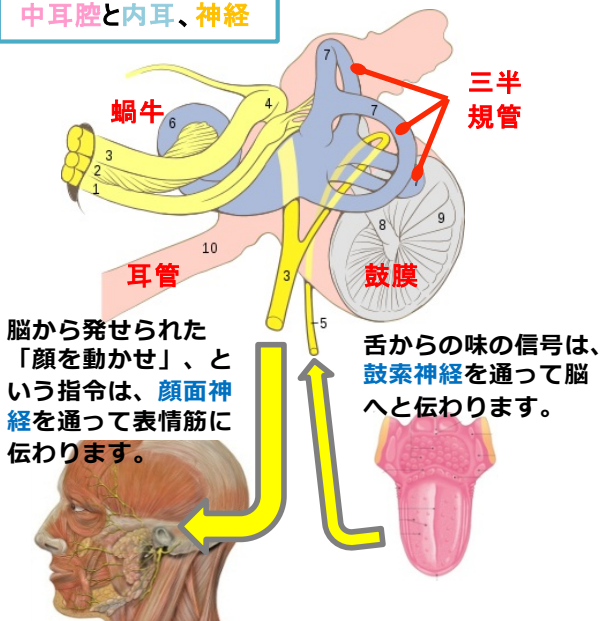


初回手術でとり残した真珠腫を摘出します



鼓膜とアブミ骨がやっと連結します(伝音再建)

中耳腔と内耳、神経



●鼓室形成術の合併症

出血や創感染等一般的な合併症の他に、脳とつながる耳に特有の症状がでることがあります。

- ・ 術側の舌前の味覚低下（鼓索神経の障害）
- ・ 感音難聴や耳鳴（頭蓋骨を削る音が刺激になる）
- ・ めまい（三半規管の障害）
- ・ 術側の顔が麻痺（顔面神経の障害）
- ・ 頭蓋内合併症（脳の炎症や髄液漏など）
- ・ 静脈洞からの大量出血 など

これら手術による合併症は、治療を放置して真珠腫が進行しても生じる症状です。初期の段階で手術すれば、合併症の危険も下がります。